Prescriptions anticipées et niveau de soins

FICHE SOCLE DOTR
VERSION 1
Mise à jour : Octobre 2026

Décider avant l'urgence, avec la personne : volontés, niveau de soins, prescriptions anticipées, transmission au 15.
EHPAD · MAS · FAM · EAM · IME — médecin coordonnateur / médecin d'établissement, médecin traitant

À RETENIR

Aggravation prévisible : rechercher les volontés, tracer un niveau de soins, rédiger des prescriptions anticipées personnalisées, les rendre accessibles la nuit et au 15. Niveau de soins limité ≠ absence de soins.

Sources : HAS, réduire les hospitalisations non programmées des résidents d'EHPAD (07/2015) · CSP L1110-5-1 · SFAP, fiche Urgence Pallia

LES VOLONTÉS DE LA PERSONNE

- **Directives anticipées** (majeur) : s'imposent au médecin, sauf urgence vitale le temps de l'évaluation et si manifestement inappropriées (refus après **procédure collégiale**, motivé). Les plus récentes prévalent ; conservées dans le **DMP**.
- **Personne de confiance** : désignation écrite cosignée ; son témoignage **prévaut sur tout autre** ; proposée à l'admission en ESMS. Majeur protégé avec représentation : autorisation du juge.
- **Personne non communicante** : communication alternative et améliorée ; l'expression non verbale a la **même valeur juridique** que l'expression verbale.

Sources : CSP L1111-11, L1111-6, L1111-6-2 (loi n° 2026-404 du 26/05/2026) · CSP R4127-37-1 · CASF L311-5-1, D311-0-4

NIVEAU DE SOINS ET LATA

- Niveau de soins tracé et daté (proposition DOTR, cases de la fiche Urgence Pallia) : hospitalisation **souhaitée / envisageable / non souhaitée** ; réanimation **oui / non**.
- Personne hors d'état de s'exprimer : limitation ou arrêt **après procédure collégiale**, incluant si possible le **médecin référent de la structure médico-sociale** ou le **médecin référent en téléconsultation** ; avis motivé d'un consultant sans lien hiérarchique.
- Décision **motivée** au dossier ; personne de confiance (à défaut famille) informée. Confort et soins palliatifs **maintenus**.

Sources : CSP L1110-5-1 (loi n° 2026-404) · CSP L1111-4 · CSP R4127-37-2 · SFAP, Urgence Pallia (06/2017)

PRESCRIPTIONS ANTICIPÉES PERSONNALISÉES

- Nominatives, écrites, datées, signées, **qualitatives et quantitatives** : critère objectif de déclenchement, molécule, dose, voie, délai, **nombre maximal** de répétitions, surveillance, seuil d'appel.
- Situations à anticiper : douleur, dyspnée, encombrement, angoisse ou agitation, convulsions, hémorragie (fiche Urgence Pallia).
- Midazolam : fiche DOTR « Midazolam en soins palliatifs » (l'outil génère une prescription anticipée nominative).
- Injections : **IDE** (arrêté du 26/06/2026, art. 4). Nuit sans IDE : IDE d'astreinte, HAD ou 15 ; AS / AES / éducateurs n'injectent pas.

Sources : CSP R4311-6 1° et 2° (décret n° 2025-1306) · arrêté du 26/06/2026 (actes), art. 2 et 4 · SFAP, Urgence Pallia

LOI N° 2026-404 : CE QUI CHANGE EN ESMS

- **Plan personnalisé d'accompagnement** : proposé après annonce d'une affection grave, aggravation d'une maladie chronique ou début de perte d'autonomie ; volet inconfort et douleur ; annexé aux directives anticipées ; décret d'application prévu.
- EHPAD, MAS, FAM : **volet soins palliatifs** du projet d'établissement (organisation, EMSP, HAD, formation).
- EHPAD : **conventions avec l'EMSP et l'équipe mobile gériatrique** ; référent chargé de l'accès aux soins palliatifs.

Sources : CSP L1110-10, L1110-10-1 · CASF L311-8-1, L312-7-1-1 (loi n° 2026-404 du 26/05/2026, JO du 27/05/2026)

TRANSMETTRE : NUIT, DLU, 15

- **Fiche Urgence Pallia** (SFAP), remplie par le médecin, « destinée au médecin intervenant en urgence » : au dossier et dans le DLU ; envoi au SAMU selon l'organisation locale.
- DLU : directives anticipées (existence, lieu), personne de confiance, mesure de protection, niveau de soins.
- L'équipe de nuit sait **où** trouver niveau de soins et prescriptions anticipées (proposition DOTR).
- Un niveau « non souhaitée » **n'empêche pas d'appeler le 15** : le régulateur décide avec ces informations (proposition DOTR).

Sources : SFAP, Urgence Pallia (06/2017, PDF 05/2025) · HAS, DLU-EHPAD (MAJ 29/04/2026) · OMéDIT CVL (02/2025)

IME : LA PERSONNE MINEURE

- Pas de directives anticipées ni de personne de confiance (**réservées au majeur**).
- Décisions avec les **titulaires de l'autorité parentale** ; consentement du mineur recherché s'il est apte. Refus parental aux conséquences graves : **soins indispensables**.
- LATA chez un mineur : avis des titulaires de l'autorité parentale, sauf urgence.
- À 18 ans : proposer personne de confiance, directives anticipées ; vérifier une mesure de protection (proposition DOTR).

Sources : CSP L1111-4, L1111-6, L1111-11 · CSP R4127-42, R4127-37-2 III · proposition DOTR

HORS CHAMP

Aide à mourir (loi n° 2026-794 du 18/08/2026) : procédure distincte, applicable après les textes réglementaires, non traitée ici.

Sources : FHF, loi du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir (08/2026)

Fiche DOTR, à adapter avec le médecin coordonnateur ou le médecin de l'établissement. Les mentions « proposition DOTR » ne viennent pas d'un texte. Ne remplace ni les procédures de l'établissement ni l'avis médical.

Vision Moderne de la Santé
Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.